

12 - 01-Révision de la Sémiologie de l'appareil locomoteur (Teams)

- Pr. GHAZI

Je suis rhumatologue et on va voir aujourd'hui la sémiologie de l'appareil locomoteur. Au fait, on va faire une révision aujourd'hui sous forme de cas clinique. Est-ce que vous m'écoutez ? Vous m'entendez ? Oui, madame.

Oui, parfait. Alors, est-ce que vous avez vu votre cours, le cours que j'ai mis sur la plateforme ? Est-ce que vous avez vu le cours sur la plateforme ? Oui, non ? Imane Shamsabd Rahim, Houssam Nisrin. Bien, répondez-moi.

Est-ce que vous avez révisé le cours que j'ai mis sur la plateforme ? La sémiologie de l'appareil ? Non ? Vous avez le cours, est-ce que vous l'avez révisé ? Oui ou non ? Vous avez révisé ? Donc, on peut faire aujourd'hui des QCM, c'est ça ? S'il vous plaît, répondez-moi parce que... Oui, madame. Merci. D'accord.

Donc aujourd'hui, on va voir le premier cas clinique. On va détailler ça petit à petit. C'est comme ces QCM que je vais vous donner lors de l'examen.

C'est pratique et vous pouvez facilement répondre si vous avez vu votre cours. Alors, si je vous dis que c'est une patiente, Aisha, qui est âgée de 55 ans. Elle est fonctionnaire à la banque.

Elle consulte pour des douleurs des deux genoux qui ont évolué depuis un an. Et sa douleur a été cotée par l'échelle visuelle analogique, l'EVA, l'échelle visuelle analogique. Et son intensité, il est à 60 mm sur 100.

Elle est gênée par la marche, par la station debout prolongée et quand elle monte les escaliers. Elle est soulagée par le repos et ne peut plus faire son sport favori depuis plus de trois mois. Alors, quand je vous dis ça, d'après ce cas clinique, il y a des questions après, mais moi j'ai envie qu'on analyse d'abord ce cas clinique.

Analysons ça ensemble. Dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez sur ce cas clinique? Analysons ligne par ligne. Si je demande à Wissal, si je demande à Wissal, Wissal, t'es là? Wissal, Wissal, t'es là? Oui.

Alors, est-ce que tu peux parler? Tu peux parler? Active ton micro. Wissal, tu es là? Tu as activé ton micro? Non, ma connexion est médiocre. Ben, d'accord.

Alors, j'aimerais bien que quelqu'un parle, genre Soukeina Hned. Soukeina, est-ce que tu peux parler? Est-ce que ton micro peut être activé? Bravo Soukeina, je crois que je t'entends. Soukeina, tu peux parler? On a juste une petite heure.

Il faut qu'on avance. Allez Soukeina, ton micro est activé. Allez.

Est-ce que je ne vous entends pas? Activez votre micro. Bon, est-ce que quelqu'un pourra prendre la parole? Ben, c'est dommage si vous ne pouvez pas prendre la parole. J'ai envie que ça soit interactif.

Oui, c'est qui avec moi? C'est magnifique. Merci d'avoir répondu. Alors, dis-moi Abdelbast, qu'est-ce que tu peux déduire de la première ligne? De vraiment la première ligne là? Qu'est-ce que tu peux déduire? D'abord, la déduire qui évolue depuis un an.

Non, attends. Déjà, cette première ligne. Il y a déjà quelque chose à dire sur la première ligne.

Elle est un peu âgée. Elle est un peu âgée? C'est ça? Oui. Alors, pour toi, sujet âgé, c'est à partir de quel âge? 50 ans.

50 ans. Au fait, Abdelbast, l'Organisation Mondiale de la Santé, les autres peuvent écrire s'ils ont des idées. L'Organisation Mondiale de la Santé a défini un sujet âgé.

Je pourrais enlever ça, comme ça vous pouvez voir la mimique de mon visage. L'Organisation Mondiale de la Santé a défini un sujet âgé à partir de l'âge de 65 ans. D'accord? Donc, 55 ans, ce n'est pas sujet âgé.

C'est encore un adulte. Un adulte, je ne vais pas dire adulte très jeune ou adulte jeune. Donc, voilà.

Donc, la première ligne, c'est ça. Quoi d'autre? Juste sur la première ligne. On a des informations dans la première ligne.

Dites-moi. Madame? Oui? Elle est fonctionnaire dans une banque, ça veut dire qu'elle passe son temps debout? C'est magnifique. Bravo, bravo.

C'est très important de connaître la fonction de la personne. Au fait, elle travaille dans une banque. On peut dire que soit qu'elle est tout le temps dans un bureau où les genoux accroissent ou alors elle est tout le temps debout à faire des va-et-vient, à ramener de l'argent, à ramener du courrier.

D'accord. C'est parfait. Il y a une information qui est aussi importante.

C'est la première, c'est le premier mot. C'est une patiente. C'est une femme.

Donc déjà, si on veut se résumer, qu'on est devant une femme, adulte, je ne vais pas dire que c'est un sujet âgé, que c'est une patiente qui est active. Elle a une fonction, d'accord, et qui travaille. Donc elle sollicite ses genoux.

Alors, qu'en est-il de la deuxième ligne? Qu'est-ce qu'on peut déduire de la deuxième ligne? Elle consulte pour des douleurs des deux genoux évoluant depuis un an. Dites-moi, qu'est-ce que

vous en dites? Les douleurs évoluent plus de trois mois, c'est une douleur. C'est toujours Abdoulbast qui parle? Oui.

Bravo, bravo. Donc, Abdoulbast nous dit que c'est une douleur qui évolue depuis plus d'un an, c'est-à-dire que c'est une douleur qui est chronique. Abdoulbast, est-ce qu'on peut revoir c'est quoi une douleur chronique? Est-ce que tu pourras me dire c'est quoi une douleur chronique? C'est une douleur qui évolue durant plus de trois mois.

Plus de trois mois, bravo, c'est magnifique. Alors, on a la douleur, elle peut être soit inférieure à trois mois, si on veut être binaire, oui ou non. Inférieure à trois mois, c'est aiguë.

Plus de trois mois, c'est chronique. Pour être un peu plus précis, il y a six semaines et trois mois. Inférieure à six semaines, c'est aiguë.

Entre six semaines et trois mois, c'est sub-aiguë. Et inférieure à trois mois, c'est chronique. Est-ce que vous me suivez? Messieurs, dames, est-ce que vous me suivez? Oui.

Merci. Merci. Alors, je vais dire quelque chose.

Merci, Yasmin, de répondre. Alors, Mona me dit que, pour la première plaque, elle me dit qu'elle est restée assise pendant de longues heures. Bravo, c'est ça.

Ali, le couadeur, me dit que peut-être qu'elle est ménopausique doux et peut avoir un problème de cartilage. Ali, moi, à mon stade, maintenant, je ne peux pas conclure à ce que tu as dit. Tu as parlé de ménopause et tu as parlé de cartilage.

Donc, tu as pensé à la ménopause et tu as pensé au cartilage. Je pourrais penser à la ménopause et automatiquement à l'os, parce que la femme, quand elle est ménopausée, la première des choses, elle commence à perdre au niveau de l'os. Tu me dis qu'elle est grosse et peut-être qu'elle aura un problème de cartilage.

J'aurais compris. Ali, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, ma réflexion? C'est une belle réflexion, ce que tu as fait, mais la relation entre ménopause et cartilage, c'est beaucoup plus ménopause et os, ménopause et os théoporose, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ali, tu pourras écrire un petit commentaire si tu n'as pas le micro. Oui, parfait.

Alors, Abdelbast, tu m'as dit que la patiente, elle consulte pour des douleurs des deux genoux évoluant depuis un an. Cette phrase, tu as conclu de cette phrase une seule chose. Tu as conclu que c'est une douleur qui est chronique, qui est plus de un an.

Est-ce que les autres sont d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'autre? Douleurs bilatérales. Douleurs bilatérales. Bilatérales des deux hanches? Des deux genoux.

Des deux genoux, d'accord. Les autres, ils peuvent écrire des commentaires. C'est une

arthralgie.

Oui? C'est une arthralgie. Magnifique, le mot arthralgie est magnifique. Alors, regarde Abdelbast, il y a ici le mot douleur.

C'est vous, c'est moi. Alors, il y a ici le mot douleur et des deux genoux. Les genoux, ce sont des articulations.

Douleur des genoux veut dire arthralgie. Arthralgie des deux genoux. On peut dire que c'est une fille.

Madame, c'est du polyarthralgie. Que quelqu'un coupe son micro. Je crois qu'il faut couper un micro.

Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Parfait. Alors, voilà, je disais que c'est une douleur des deux genoux. C'est-à-dire que c'est une arthralgie de deux articulations.

C'est une biarthralgie. Bi, c'est deux. Douleur articulaire veut dire arthralgie.

Algie articulaire. Vous êtes d'accord? Messieurs, dames, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous dormez? Pour Irania. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle d'arthralgie au niveau des deux genoux? C'est une biarthralgie, c'est-à-dire que c'est une arthralgie de deux genoux, de deux articulations.

Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire que c'est une polyarthralgie? Polyarthralgie. Parce qu'il y a deux articulations. Donc, c'est plus de deux.

C'est plus de deux. Alors, tout à l'heure, vous avez vu votre cours. Quand il y a une articulation, c'est mono.

Deux articulations, c'est bi. Et trois articulations, c'est polyarthralgie. D'accord? Tu sais, Rania, si tu me dis que c'est une polyarthralgie, moi je vais penser que cette patiente a plus de trois articulations douloureuses.

D'accord? Non, madame, je parle de polyarthralgie parce que chaque genou contient deux articulations. Donc, on parle de deux articulations pour chaque genou. Non, non, non, ne parle pas, ne va pas trop loin, Rania.

L'articulation du genou, je n'ai pas envie que tu penses que c'est l'articulation pathéla, le femur, entre le tibia et le femur, et entre le tibia et le proximal, et entre le tibia et le péronné. Non, l'articulation du genou, c'est une seule articulation. D'accord? Tu sais que l'articulation de l'épaule, il y a cinq articulations.

Mais, quand on veut faire le comptage, c'est l'articulation de l'épaule. D'accord? D'accord, madame. Rania, ne pense pas trop loin, ne va pas trop dans l'anatomie maintenant.

D'accord. Le genou, c'est une seule articulation. Alors, donc, on conclut pour la deuxième phrase que c'est une douleur des deux genoux.

Donc, ce sont des arthralgies des genoux. Ce sont des arthralgies chroniques, comme a dit Abdelbaste. Alors, qu'est-ce qu'on pourra déduire de la deuxième ligne? Ceux qui n'arrivent pas à avoir le micro, ils peuvent écrire.

J'aimerais bien vous lire. Sarah. Sarah, tu dis que ce sont des douleurs qui sont sévères, un peu sévères.

Écoute Sarah, tu es médecin. Il n'y a pas un peu, chichouilla, malheureusement. C'est sévère.

C'est sévère. La patiente a une EVA douleur à 60. C'est plus de 50.

Juste pour vous dire que les patients qui ont un cancer, ils ont, quand ils ont trop mal, ils ont une EVA douleur à 10 sur 10 ou à 100 mm sur 100. D'accord? C'est une douleur qu'on dit, elle est très intense. D'accord? Là, elle est à 60, elle est intense.

C'est une douleur qui est intense. La patiente doit se tordre de douleur. D'accord? D'accord? Quand vous me dites 60, je comprends que la patiente a une douleur qui est intense.

Ok? Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs-dames? Oui, madame. Parfait. Zineb, tu dis que c'est une douleur qui est intense.

Bravo. Safa, tu dis que ce sont des douleurs qui sont modérées. Plutôt, on est dans l'intensité.

Il faut parler douleur intense ou très intense. D'accord? Voilà. Alors, on passe à la quatrième idée.

La patiente est gênée par la marche, la station debout, prolongée et la montée des escaliers. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous n'arrivez pas à avoir le micro, vous m'écrivez. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça veut dire le seuil de retentissement des douleurs sur les activités quotidiennes de la patiente.

D'accord, c'est-à-dire que la patiente n'arrive pas à marcher, que la station debout prolongée lui fait mal et aussi à la montée des escaliers. Donc, pour toi, ce sont des signes de retentissement. C'est ça, Sarah? Oui, madame.

Alors, au fait, Zied a dit que c'est une douleur mécanique car elle est calmée par le repos et elle est présente à l'effort. Au fait, Zied, tu as sauté une étape, on n'est pas encore à cette douleur. Toi et Abir, vous nous suivez juste étape par étape.

Et Mona dit que c'est un retentissement sur les activités quotidiennes. Yasmin dit qu'il y a une limitation de la marche. Alors, moi, ce que je vais vous dire restant trop simple.

On est médecin, on analyse juste idée par idée. La patiente est gênée par la marche. C'est-à-dire que la marche gêne la patiente au niveau de ses genoux.

Au fait, ça ce sont des facteurs déclenchants. C'est-à-dire que quand la patiente marche, quand elle a une station debout prolongée et quand elle monte les escaliers, ça ce n'est pas un retentissement. Le retentissement peut-être qu'on le verra plus tard.

Là, ce sont des facteurs qui déclenchent la douleur au genou, c'est cette patiente. Elle dit que quand elle marche, elle est gênée. Quand elle est debout de façon prolongée, elle est gênée.

Et quand elle monte les escaliers. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je veux dire. Messieurs, Mesdames, Zineb, Imane, Imane Mourad.

Imane, tu viens de te réveiller ? Parfait. Donc, on a dit que la marche, la station debout prolongée, et merci Zineb d'avoir répondu, et la montée des escaliers, ça lui fait mal. Donc, ce sont des facteurs déclenchants.

Alors, on arrive à la deuxième étape. Et la patiente, la douleur au niveau des genoux est soulagée par le repos. Et déjà, Abir et Zied ont déjà répondu que la douleur est calmée par le repos.

Donc, c'est une douleur qui est mécanique. Est-ce que quelqu'un pourra me définir ? C'est très important. Abir me dit que c'est une douleur mécanique puisqu'elle apparaît après un effort.

Ah ben, c'est normal. Je ne sais pas. Au niveau du dos, par exemple, quelqu'un a porté une charge lourde de 100 kilos.

Après, il a eu mal au dos. Il a déposé les 100 kilos. Il n'a plus mal au dos.

Ça, c'est une douleur qui est mécanique. D'accord ? Vous avez compris ça ? Oui ? Raja, tu n'as pas répondu. Je crois que tu es en train de dormir.

Alors, il y a de nouveaux messages qu'on va lire. Oui, oui. Merci Yasmin.

Merci Zineb. Abir, elle est maximale en fin de journée. C'est quoi qui est maximale en fin de journée ? Salma me dit que c'est une douleur qui est calmée par le repos.

Et Abir m'explique davantage qu'il n'y a pas de réveil nocturne. Et elle me dit que c'est la douleur qui est maximale en fin de journée. Au fait, la douleur mécanique, vous voyez comment c'est cette douleur mécanique ? C'est comme si on a une grosse pierre que tu déposes sur ton pied.

Tu enlèves la pierre et c'est terminé. L'histoire est terminée. D'accord ? Donc, c'est ça, une douleur qui est mécanique.

Alors, est-ce que quelqu'un pourra me dire c'est quoi la différence entre une douleur mécanique

et une douleur inflammatoire ? J'aime bien que vous sachiez c'est quoi ces différences. Messieurs, Mesdames, donc pour moi, Raja, toi tu dors. Oui, Sarah ? La douleur mécanique, elle est déclenchée par l'effort, alors que l'inflammatoire, elle est spontanée.

Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec l'effort. Magnifique. Est-ce que tu pourras dire quelque chose d'autre, Sarah ? Donne-moi deux autres indices.

Pour le réveil nocturne, pour l'inflammatoire, il provoque le réveil nocturne, alors que le mécanique non. Magnifique. Alors, Sarah me dit que la douleur inflammatoire, c'est une douleur qui est spontanée et elle fait des réveils nocturnes.

Alors que la douleur mécanique, c'est une douleur qui ne réveille pas la nuit. Au fait, la douleur mécanique peut réveiller la nuit, mais au changement de position. Il y a beaucoup de patients qui vont te dire, quand je change de position, quand je mets un genou sur un genou, ça ce n'est pas un réveil nocturne, ça c'est un changement de position.

D'accord ? Alors, je vais lire quelques commentaires que j'adore. Il y a... Alors, alors, alors... Quelques commentaires... Il y a Abdelkader qui a expliqué, qui a essayé d'expliquer. Abdelkader Radhi me dit que la douleur mécanique, c'est la dégénérescence du cartilage articulaire.

C'est possible que ce soit la dégénérescence articulaire, Abdelkader. Au fait, je vais te dire que c'est la cause principale de la douleur mécanique. Mais il n'y a pas que ça.

Il y a d'autres choses. Par exemple, Abdelkader, quand je te dis que c'est un patient qui a mal au niveau du dos, au niveau lombaire, et c'est un patient qui a 50 ans et il a mal au niveau lombaire, et on fait une IRM, il n'y a pas de dégénérescence discale. Il n'y a pas de dégénérescence du cartilage ou du disque.

Par contre, il a un canal lombaire qui est rétréci. C'est-à-dire que son canal rachidien est rétréci. Ça, c'est une douleur qui est mécanique.

C'est un problème qui est mécanique. Rappelez-vous toujours de cette pierre qui est posée sur le pied qui donne un problème mécanique. Alors Yasmin, qui ici me dit que la douleur mécanique apparaît après un mouvement, mais l'inflammatoire, elle apparaît même au repos.

C'est extraordinaire, ça. Ziad, conforte ce que dit Yasmin. Il dit que c'est une douleur qui a un lent dérouillage articulaire.

Bravo. Pourquoi bravo, Ziad? Parce que la douleur inflammatoire, elle survient spontanément le matin au réveil et laisse le patient avoir un dérouillage matinal. Par exemple, chez nous, dans notre consultation, les malades qui sont rhumatisants, qui ont un rhumatisme inflammatoire, on leur donne des rendez-vous à 11h du matin parce qu'ils n'arrivent pas à se réveiller le matin tôt.

Par contre, les malades qui sont arthrosiques, ça ce sont des malades qui se réveillent le matin

tôt, il n'y a pas de dérouillage matinal, c'est à l'aise, d'accord? Alors, Imen me dit que la douleur mécanique est localisée. Sérieusement, Imen, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi pour la douleur mécanique et localisée.

La douleur mécanique, localisée, c'est un autre tiroir. Moi, j'adore expliquer ça en tiroir. Je veux vous dire que on a une chambre ou plutôt on a un placard, d'accord? Et dans ce placard, où on a rangé plein d'habits, il y a plusieurs tiroirs, d'accord? Et tu sais ce que tu as fait maintenant? C'est comme si Imen, Imen le ami, Imen, c'est comme si tu as pris des sous-vêtements et tu les as mis avec les jeans dans le même tiroir.

D'accord? La douleur mécanique, c'est un caractère de la douleur. La localisée ou généralisée, c'est un autre tiroir. Tu vois? Tu vas être très perfectionniste, tu mettras dans tes tiroirs un, tu mettras les sous-vêtements, un, tu mettras tes chaussettes, un, tu mettras tes jeans, un, tu mettras tes t-shirts, tu vois ce que je veux dire? Imen, réponds-moi, est-ce que tu as compris que la douleur mécanique n'a rien à voir avec la localisation? Est-ce que vous avez tous compris cette histoire? Parce que moi, j'aime bien poser des questions pour voir si les étudiants ont compris, et j'aime bien poser ce genre de questions dans les QCM.

Bravo Imen, ça me fait plaisir que tu aies compris ça. Alors, Zineb Tazi me dit que la douleur inflammatoire est calmée en fin de journée. Zineb, est-ce que tu as le micro? Zineb, est-ce que tu as le micro? Zineb, si tu n'as pas le micro, tu as le micro, magnifique.

Alors Zineb, dis-moi, la douleur inflammatoire est calmée en fin de journée. Explique-moi davantage. Est-ce que... En fait, parce que la douleur mécanique, normalement, en fin de journée, elle s'empire, parce qu'on est plus fatigué en fin de journée.

Mais par contre, la douleur inflammatoire, puisqu'elle n'a pas un rapport direct avec l'effort, donc en fin de journée, elle se calme. Malheureusement, Zineb, je vais te dire que les patients qui... Une douleur mécanique, elle est calmée par le repos et elle est... Elle survient à l'effort. La douleur inflammatoire, tu sais que ce sont des malades qui, le matin, ils ont une raideur matinale et pour la journée, parce qu'ils étaient actifs, ils disent qu'il me faut un temps de dérouillage.

Aïd, il commence à travailler et en fin de journée, par exemple, à 10 heures du soir, à minuit, à 3 heures du matin, la douleur recommence et donc, la douleur inflammatoire n'a rien à voir avec le repos, n'a rien à voir avec l'effort. D'accord, Zineb ? Je veux que tu restes juste... Tout à l'heure, elle a dit que sur l'articulation du genou, il y a plusieurs articulations. Non, c'est une seule articulation.

La douleur inflammatoire ne survient pas à l'effort et ne survient pas au repos. C'est une douleur qui n'a rien à voir avec tout ça. D'accord ? C'est une douleur qui survient la nuit.

C'est une douleur avec un dérouillage matinal qui n'a rien à voir avec l'effort. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on est reposé qu'on ne va pas avoir la douleur inflammatoire. Ce n'est pas parce

qu'on est fatigué le soir qu'on ne va pas avoir la douleur inflammatoire.

C'est une douleur indépendante de l'effort. D'accord ? Zineb ? D'accord. D'accord, merci.

Parfait, ça marche. Je crois qu'il va falloir qu'on avance un peu. On est toujours à la première plaque.

Et... Elle ne peut plus faire son sport favori depuis trois mois. Répondez-moi en une seule réponse. C'est quoi ça ? Elle ne peut pas faire son sport depuis trois mois.

C'est quoi ? On appelle ça comment ? Un mot, deux mots faites. Retentissement. Bravo Abdelbast.

C'est un retentissement, bravo Selma. C'est le retentissement fonctionnel. Et là, cette douleur a un retentissement fonctionnel.

Alors, je passe à l'examen de cette patiente. Je vais l'examiner. Elle vient en consultation.

Elle fait une marche. Ça marche avec une boiterie. Elle arrive avec une canne à la main.

Et quand on fait la palpation, comme je vous ai montré sur le cours, on a un épanchement du genou droit. Il y a du liquide. Vous vous rappelez du signe de flots et de glaçons ? Et le choc rotulien ? Oui ? Est-ce que vous vous rappelez de ça durant le cours ? Messieurs, Mesdames, Rania, que je n'ai jamais entendue.

Alors, personne ne répond ? Vous ne vous rappelez pas du choc rotulien ? Zineb, Imane ? Oui, Madame. Parfait. Alors, donc, il y a une limitation de la flexion du genou, qui est douloureuse, elle est limitée, du côté droit, à 90 degrés, et le reste de l'examen somatique est sans particularité.

Alors, vous me dites, vous écrivez, j'ai bien envie que vous écriviez, et tout le monde écrit, j'ai envie d'avoir beaucoup de messages. Comment vous classez cette douleur ? Est-ce que c'est une monoarthrite du genou droit ? Est-ce que c'est une douleur chronique des genoux ? Est-ce que c'est une polyarthropathie ? Yasmin, c'est à toi la question. Est-ce que c'est une douleur aiguë ? Répondez-moi, et vite, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bravo.

Tout le monde est bien d'accord, regardant la raison. Est-ce que c'est une monoarthrite du genou droit ? Déjà, on a deux genoux, c'est éliminé d'avantage. Et puis, mono, non, et arthrite, on n'est pas devant une arthrite.

On a bien dit, ici, que ce n'est pas une arthrite, c'est une douleur qui est gênée par la marche, la station, elle est soulagée par le repos, donc c'est une douleur qui est mécanique. On n'est pas du tout dans l'inflammation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis, ce n'est pas une polyarthropathie.

Polyarthropathie, c'est plus de 3 articulations. Et puis, ce n'est pas une douleur aiguë, ça évolue

depuis plus de 1 mois. Bravo les amis, je suis contente que vous ayez répondu.

Vous aurez ce type de questions. Alors, à l'examen, on a examiné, on a trouvé du liquide dans l'articulation. On a trouvé du liquide dans l'articulation.

J'essaie de voir. On a trouvé du liquide dans l'articulation. Donc, Ali, Oumaïman, Nidal, tout le monde a répondu que c'est la deuxième réponse.

C'est la douleur chronique. Ça me fait énormément plaisir. Alors, on a trouvé un épongement articulaire et on a recherché des points douloureux.

On a recherché aussi la douleur à la mobilisation des hanches. Vous savez qu'il y a un lien étroit entre les hanches et le genou. Alors quels sont les diagnostics possibles à votre avis ? Est-ce que c'est une arthrose des genoux ? Est-ce que c'est une arthrite rhumatismale dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire chronique ? Est-ce que c'est une arthrite septique ? Est-ce que c'est une ostéoporose ? Répondez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors tout le monde répond, alors tout le monde a répondu, Zineb en premier, c'est une arthrose des genoux, c'est une arthrose des genoux, Alaa, Hajar, Oumayma, Boutaina, tout le monde, Kautar, Fatem Zahra a dit que c'est une arthrose des genoux, Raja, enfin il s'est réveillé, voilà, Ekram aussi, et moi j'attendais Ali qui me répond, il dit des choses, Ali tu n'as pas répondu, tu n'es pas d'accord, tu ne sais pas c'est quoi, Ziyad, Khawla, alors il y a Ziyad qui a répondu, arthrite, Ziyad tu actives ton micro, Ziyad tu actives ton micro, oui madame, dis-moi pourquoi tu as dit arthrite, au début j'avais dit arthrose, puis je me suis rappelé que l'arthrose c'était une douleur inflammatoire, donc je me suis dit, Ziyad, comment ça l'arthrose c'est une douleur inflammatoire, c'est pas une douleur inflammatoire, Ziyad depuis tout à l'heure on travaille sur ça, écoute-moi, Ziad, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si Ali le quadre est en train d'écrire que c'est la douleur mécanique, c'est une destruction du cartilage.

Mécanique, cartilage. Arthrite c'est l'inflammation. Cartilage c'est beaucoup plus mécanique.

Est-ce que tu as compris, Ziad? Arthrite, il y a le mot it. Dès que tu vois le mot it, c'est l'inflammation, d'accord? Ziad, réponds-moi, active ton micro. L'arthrose c'est mécanique.

L'arthrose c'est le meilleur modèle de la douleur mécanique. Les rhumatismes inflammatoires, l'arthrite septique par exemple quand il y a un germe dans l'articulation. Arthrite, c'est une inflammation de l'articulation.

Ça c'est inflammatoire, d'accord? Tout ce qui est arthrose et tout ce qui est douleur mécanique, c'est mécanique. Ça survient à l'effort et ça disparaît au repos. Je ne sais pas si tu as compris, Ziad.

Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu n'as pas compris, tu me dis. Donc, si j'ai bien compris, l'arthrite c'est une douleur inflammatoire et l'arthrose est une douleur mécanique. Bravo,

je vais te féliciter.

Je suis contente. Est-ce que vous avez tous compris? Dites-moi juste un oui ou un non. Oui, madame.

Merci, Sarah. Merci, Noemane. Merci, Omeima.

Kautar aussi, Sheyman. Parfait. Ça me fait plaisir.

Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Imane, c'est bien. Zineb, est-ce que vous avez compris? Oui. Parfait.

Alors, on va passer rapidement aux autres cas cliniques. J'attendais... J'ai une question. Pour l'esclosé, ça va donner une douleur de type inflammatoire ou bien... Bravo pour la question.

C'est une très belle question, Abdelbaste. J'attendais à Ali dire ça. Moi, j'ai fait un intrus ici.

Je l'ai fait exprès. Attendez. L'intrus, c'est ça, l'ostéoporose.

Je me suis dit que les étudiants vont dire « Ah, elle a 55 ans, elle doit être méloposée. Ah, c'est sûr que c'est une ostéoporose. » Écoutez, on n'est pas dans l'ostéoporose maintenant.

On est juste dans tout ce qui est douleur mécanique, inflammatoire, arthrose, arthritisme. D'accord? L'ostéoporose, c'est l'os. Ce n'est pas le cartilage, ce n'est pas le disque.

D'accord? On s'en fout qu'elle soit méloposée ou pas méloposée. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Abdelbaste? Oui, madame. Je suis patient, par exemple.

Il souffre de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie. Rappelle-toi cette jolie phrase que je vais dire.

L'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse jusqu'à l'âge de la fracture. La patiente fait une ostéoporose. Une ostéoporose, c'est un défaut de l'architecture osseuse.

Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire ici. Et j'ai fait ça, le QCM, juste pour vous induire en erreur. L'ostéoporose n'a rien à voir avec ça.

La patiente ostéoporotique... Oui, Abdelbaste, je t'écoute? Oui, j'ai bien compris, madame. Merci. L'ostéoporose, c'est un déficit, c'est un défaut architectural osseux.

La patiente a une ostéoporose qu'elle développe de façon très silencieuse. L'ostéoporose ne fait pas mal. Elle a trop mal au dos.

On fait une radiographie, on trouve une fracture de la vertèbre. Oubliez l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un cours que vous allez voir en quatrième année.

C'était juste pour vous induire en erreur et je suis contente parce que je vous ai induit en erreur. C'est une arthrose des genoux. Bravo tout le monde.

On passe à l'autre cas clinique. On a encore plusieurs cas cliniques et on n'a pas beaucoup avancé. Il me reste dix minutes avec vous.

C'est le deuxième cas clinique d'une patiente qui a 35 ans. Elle est institutrice. Depuis un mois, elle a des douleurs au niveau des poignets, les coudes, les chevilles.

Elle souffre la nuit et se réveille souvent. Elle souffre la nuit. Remarque bien ça.

Zineb, Zineb Tazi, remarque ça. Elle se réveille souvent pour prendre des antalgiques. Elle est très gênée le matin.

Elle n'arrive pas à se réveiller. Elle est très gênée à cause d'une raideur qui est matinale. Je vais vous relire.

Femme, 35 ans, fonctionnaire, un mois, les poignets, les coudes, les chevilles, souffre la nuit, se réveille pour prendre des antalgiques Elle est très gênée le matin. Elle a une raideur matinale de 40 minutes. On l'examine.

Il n'y a pas d'arthrite. Il n'y a pas de liquide. Arthrite, c'est liquide, rougeur, chaleur.

On a des douleurs à la mobilisation des articulations. Les articulations sont douloureuses à la mobilisation. Et puis, il y a une diminution de la flexion du poignet gauche.

Et l'examen est normal. À votre avis, j'aimerais que vous répondiez, Est-ce que c'est une polyarthrite? Est-ce que c'est une oligoarthrite? Est-ce que c'est des polyarthralgies inflammatoires? Est-ce que c'est une polyarthropathie? Je compte jusqu'à cinq cette fois-ci et je veux vos réponses. Alors, Zied, on va en reparler.

Mona me dit des choses, Raja aussi. La majorité sont d'accord sur le 3 et sur le 4. Oumeymed dit 4. Juste pour vous dire. Zineb me dit 3. Bravo, bravo, bravo tout le monde.

Et Zied, tu as dit 1. C'est toi le seul qui a dit polyarthrite. Alors, j'ai envie d'éclaircir une chose avec vous. Est-ce que vous voulez les QCM pour ce qui est ma matière, moi? Est-ce que vous voulez des QCU, c'est-à-dire à choix unique, ou vous voulez des QCM à choix multiple? Juste dites-moi, multiple ou unique.

Je ferai ce que vous voulez. C'est qui qui a répondu? C'est magnifique. Tout le monde dit U. Allez, c'est parti pour le U. C'est des QCU.

Je vais serrer un peu. Si c'est U, il faut que la réponse ne soit pas claire. Parfait, d'accord.

Ma partie, ce sera des QCU. Je vous promets, parole d'homme. Alors, on revient à notre cas

clinique.

Zied, après, je vais discuter avec toi. Est-ce que tout le monde, la majorité ont répondu que c'est des polyarthralgies inflammatoires? On revient à notre cas clinique. La patiente, elle a 35 ans, elle a mal.

Elle a mal, c'est des arthralgies. Les deux poignées, les deux coudes, les deux chevilles. C'est des polyarthralgies.

Elle se réveille la nuit, elle prend des antalgiques, c'est inflammatoire. Est-ce que tu as vu Zied? Elle se réveille la nuit, elle prend des antalgiques, elle a une raideur matinale. Ça, c'est la vraie douleur inflammatoire.

Zineb, est-ce que tu as compris c'est quoi la douleur inflammatoire? Oui. Parfait. Alors, j'ai dit qu'à l'examen, Zied, c'est pour toi ça.

J'ai dit à l'examen, il n'y a pas de penchement. C'est très important, chaque mot a une signification. Il n'y a pas de penchement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a pas de liquide.

Liquide, ça veut dire polyarthrite. Zied, est-ce que tu as compris ce que je dis? Oui, j'ai compris. Quand il y a du liquide, on parle de polyarthrite.

Quand il y a juste la douleur inflammatoire, on parle juste d'arthralgie inflammatoire. Parfait. Alors, il y a une seule personne qui a répondu la réponse 4, polyarthropathie.

Et je vais voir c'est qui cette personne que je vais nommer. Il y a quelqu'un qui a répondu la 4, je l'ai vu. La majorité ont répondu 3. Et il y a Umaima qui a répondu 4. Umaima a répondu 4, c'est magnifique.

Personne n'a répondu 4. Au fait, on va détailler ce mot. C'est une polyarthropathie. Poly, c'est plusieurs.

On a coude, poignet, cheville. Arthro, c'est des douleurs articulaires. Hepathi, c'est écrit sur le cours.

C'est pathologie. C'est une pathologie de plusieurs articulations. C'est vrai, la patiente a des polyarthralgies inflammatoires, mais elle a aussi une polyarthropathie.

Vous êtes sauvés parce que vous avez demandé des QCU, mais si c'était des QCM, j'aurais mis quelque chose comme celui-là. D'accord, c'est des polyarthralgies inflammatoires, mais c'est aussi une polyarthropathie. Est-ce que vous êtes d'accord? Messieurs, Mesdames, répondez-moi.

Parfait, merci Yasmine, merci Sheyma, merci tout le monde d'avoir répondu. C'est parfait. Quelle est la différence entre arthralgie inflammatoire et arthrite? Bravo Fatine, bravo pour la question,

parce que j'ai répondu à Zied, mais tu n'as pas saisi.

Polyarthralgie inflammatoire, c'est juste une douleur, mais qui est de type inflammatoire. Elle réveille la nuit avec le déroulage matinal. Une arthrite, par exemple, du poignet, il y a du liquide, il y a de l'épanchement, c'est ça la différence.

Épanchement avec douleur inflammatoire, ça veut dire arthrite. Épanchement sans douleur inflammatoire, ça peut exister dans l'arthrose. En consultation, c'est une arthrose du genou.

Elle a un grand épanchement au niveau du genou. C'est un épanchement dans le cadre d'une pathologie mécanique. Ce n'est pas une arthrite.

Fatine. Après, quand on a une douleur qui est inflammatoire, la douleur, par exemple une patiente a un épanchement au niveau du poignet, tu vois bien que son poignet est tuméfié, et c'est une douleur qui l'a réveillé la nuit, et elle a une réveille matinale d'une heure par exemple. Ça c'est une douleur, c'est une arthrite.

Fatine, est-ce que tu as compris? Oui madame, merci. Je récapitule. La douleur inflammatoire, l'arthrite, c'est un épanchement plus douleur inflammatoire.

D'accord? L'arthralgie, c'est une douleur inflammatoire sans épanchement. J'espère que j'ai été claire. Oui madame, merci.

Parfait. Alors, Yasmin, il faut comprendre qu'une arthropathie est la même que l'arthralgie. Non Yasmin.

L'arthropathie, c'est une pathologie de l'articulation. Elle peut être inflammatoire ou mécanique. L'arthralgie inflammatoire, c'est une algie articulaire inflammatoire.

L'arthropathie, elle peut englober le tout. L'arthropathie, c'est culture. D'accord? C'est une pathologie articulaire.

Yasmin, tu comprends? Dis-moi, réponds-moi rapidement. Yasmin, est-ce qu'elle a répondu? D'accord, merci, bravo. Alors, on va passer à Qu'est-ce qu'il y a en faveur du caractère inflammatoire chez cette patiente? Est-ce que c'est la durée de l'arrêt d'heure matinale? Est-ce que ce sont les réveils nocturnes? Est-ce que c'est le siège de l'atteinte articulaire? Est-ce que c'est le sexe féminin? Est-ce que c'est la durée de la maladie? Répondez-moi en cinq secondes.

La durée, les réveils, en faveur du caractère inflammatoire. Yasmin, il faut que tu répondes. Toi et Ziyad.

Un, deux, trois, quatre et cinq. Alors, tout le monde a répondu. Un et deux.

Alaa, Raja, Ali. Alors, tout le monde a répondu. Un et deux.

Ziyad a dit un et deux. Yasmin a répondu deux. Tout le monde a répondu.

Un et deux. Zineb a dit un et deux. Alors, le caractère inflammatoire.

La durée de l'arrêt d'heure matinale. Quand la durée de l'arrêt d'heure matinale est plus de 30 minutes, c'est un caractère inflammatoire. Bravo, ceux qui ont répondu un.

Le réveil nocturne, bravo. C'est le caractère inflammatoire. J'aimerais bien juste savoir qui a répondu trois, quatre ou juste un.

Tout le monde a répondu un et deux. Tout le monde a répondu un et deux. Il y a Alaa qui a répondu juste un, je ne sais pas pourquoi.

Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de douleur localisée. Je ne sais pas c'est qui qui a parlé de la douleur localisée. Dites-moi qui a parlé de la douleur localisée.

Quelqu'un qui a parlé de la douleur localisée. J'aimerais bien savoir c'est qui. Dites-moi qui a parlé de la douleur localisée.

Je n'arrive pas à voir. Qui a parlé de la douleur localisée? Nouveau message, moi. Bravo Imen d'avoir avoué coupable.

Voilà, Imen, je suis contente que tu aies compris que le tiroir du caractère inflammatoire contient juste des sous-vêtements. Il ne contient ni jean, ni chaussettes, ni t-shirt. Est-ce que vous avez compris? Ça, ce sont d'autres choses qui sont dans d'autres tiroirs.

J'espère que vous avez compris ça. Dites-moi oui ou non. Bravo Imen que tu aies compris ça.

Ça m'a fait plaisir. Toi, tu n'as pas répondu, Imen. Bravo, c'est bien.

Alors, revenons à un autre cas clinique. Je crois que ce sera mon dernier cas clinique. Il n'y a plus assez de temps.

Le cas clinique, c'est un truc qui est très facile. C'est un monsieur qui a 75 ans. Il a un cancer de la thyroïde depuis 4 ans.

Il a des douleurs osseuses. C'est pour toi. Des douleurs osseuses au niveau du bassin et des fémurs.

Il a perdu 10 kilos en 3 mois. On trouve un goitre. Quand on palpe ses os, il a mal.

Et les hanches sont libres et non douloureuses. Il a mal au niveau des os, au niveau du bassin et des fémurs. C'est quoi comme pathologie qu'il a ce malade? Il a quoi comme pathologie? Répondez-moi.

Là, je compte jusqu'à 3. 1... 2... 3... Sarah a répondu 2. Les autres? Il n'y a même pas d'ostéoporose dans les réponses. Yasmin, c'est bien. Khalid, c'est bien.

Zineb, y a-t-il une réponse? Parfait, bravo. Alors, revenons à ce que j'ai dit. Ce QCM, c'est juste un leurre.

C'est juste pour vous mettre dans l'embarras. Le patient, 75 ans, cancer de la thyroïde. Il a des douleurs osseuses.

Il n'a même pas de douleurs articulaires. J'ai dit ici que les hanches sont libres et non douloureuses. Est-ce que c'est une arthropathie inflammatoire, Yasmin? Il n'a pas de douleurs articulaires, ce malade.

Il a des douleurs au niveau de l'os. Est-ce que c'est une coccyte bilatérale? Parce que j'ai dit les hanches, vous allez dire AL. Les hanches, les hanches, donc c'est coccyte.

Ah non, il n'y a pas de ça. C'est une ostéopathie. L'ostéopathie, c'est une pathologie de l'os.

Tout simplement. N'importe quel monde ne nous doit pas faire peur. Je passe rapidement à un quatrième cas clinique et ce sera mon dernier cas.

J'en ai peut-être pour l'EQCM. Alors, je vous dis que c'est un plombier qui a 44 ans. Il a une douleur au niveau de l'épaule.

J'aimerais bien que vous soyez vraiment concentrés avec ce cas clinique. 44 ans, il a mal à l'épaule, à l'articulation de l'épaule, madame Yasmin. Elle est voulue depuis trois semaines.

Elle est mécanique. La mobilisation passive et active sont limitées. Je vais vous dire qu'elles sont limitées.

Elle est limitée. L'élévation antérieure et la rotation externe sont limitées. Je vais relire le cas clinique.

44 ans, douleur de l'épaule droite, trois semaines, douleur mécanique, mobilisation active et passive limitée. À votre avis, est-ce que c'est une tendinite de l'épaule? Est-ce que c'est une raideur articulaire? Est-ce que c'est une capsulite rétractive? Est-ce que c'est une rupture tendineuse? Est-ce que c'est une épaule gelée? Alors, Zineb répond trois. Zineb, tu dis que tu es déjà morte.

Ali me dit que c'est deux et trois. Zineb dit juste trois. Selma, trois, deux et trois, deux, trois, Raja, Safa, Hajar, deux et trois.

Alors, Abdelbaste dit deux et trois. Bravo. Safa dit deux et quatre.

C'est très bien. Alors, je vais vous dire. Sur le QCM, je vous ai dit dans le cours que j'ai envie que

vous reteniez cette histoire.

La mobilisation passive, c'est-à-dire le patient ne fait rien. C'est l'examineur qui fait. Elle n'est pas limitée.

C'est le patient qui fait. Il n'y a pas de problème. La mobilisation active, c'est-à-dire que le patient ne peut pas faire, mais l'examineur peut faire.

Je veux que vous reteniez une seule chose. Quand il y a une atteinte de la mobilisation active et passive, c'est une atteinte de l'articulation. Ni l'examineur, moi, ni le malade ne peut mobiliser l'articulation.

C'est une atteinte de l'articulation. Retenez ça, s'il vous plaît. Limitation de la mobilisation passive et active veut dire atteinte articulaire.

Est-ce que c'est une atteinte tendineuse de l'épaule? L'atteinte tendineuse, le patient ne peut pas mobiliser, mais l'examineur peut. C'est-à-dire que la mobilité passive, c'est possible. Une raideur articulaire, oui.

Il faut répondre raideur articulaire. C'est une raideur de l'articulation. Une capsulite rétractive, oui, c'est une atteinte de l'articulation.

La capsule s'est rétractée sur l'articulation et l'articulation ne bouge plus. Est-ce que c'est une rupture tendineuse? Rupture tendineuse, le patient ne peut pas mobiliser. C'est rompu.

L'examineur, quand il lève la main, il peut la lever. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une limitation de la mobilisation active et passive.

Une épaule gelée, elle est gelée. C'est du gel, c'est des glaçons. C'est-à-dire que c'est une atteinte de l'articulation.

Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Une main répond 2, 3 et 5, c'est la meilleure réponse. Je ne sais pas si tu as répondu juste avant, juste après.

C'est la meilleure réponse. C'est la capsule triractile, la raideur et l'épaule gelée. Oui, dis-moi.

Madame, je n'ai pas compris la dernière proposition. L'épaule gelée, elle est gelée. Est-ce que tu es déjà... C'est un rapport de la température? Ce n'est pas la température.

C'est un mot français. Quand tu dis, tu fais rentrer de la viande, un poulet, dans ton congélateur et tu dis que c'est un poulet qui est gelé. C'est vrai, c'est vrai.

Ça veut dire raideur? Ça veut dire raideur, c'est une raideur complète. Mouna me demande, s'il vous plaît, est-ce que la capsule triractile donnera une douleur inflammatoire? Mouna, je vais reformuler la phrase et je vais te la demander en question. La capsule triractile, on la voit

généralement chez les diabétiques parce que le diabète touche les capsules.

C'est une capsule qui fait l'articulation. Vous voyez, l'articulation est là. Elle est enveloppée par une capsule et cette capsule se rétracte sur l'articulation et on ne peut plus faire mobiliser notre articulation.

À ton avis, c'est une douleur articulaire ou inflammatoire? C'est une douleur mécanique ou inflammatoire? Mécanique. Bravo, tu as répondu toi-même. Madame, je suis allée... Je ne sais pas si vous m'entendez.

Je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends, dis-moi. Je suis allée... Ah oui, tu as vu qu'il y a le hit.

Tu as raison. Bravo pour ta petite réflexion. La capsule tritractile, c'est une rétraction de la capsule.

C'est vrai qu'il y a le hit. Il y a Ziad qui ne sera pas d'accord. Il y a Abdelbass non plus qui ne sera pas d'accord.

Mais la capsule tritractile, c'est juste la rétraction de la capsule sur l'articulation. Alors, il y a Safa qui me dit est-ce qu'on peut penser encore à une synovite? Où ça? Au niveau de l'épaule, elle n'a pas de synovite, elle n'a pas d'épanchement. C'est juste... Synovite, il faut qu'il y ait un épanchement.

Et l'épaule, c'est une articulation qui a assez... Il faut faire une échographie pour voir l'épanchement au niveau de l'articulation. J'aurais aimé continuer avec vous plus de QCM, mais si vous avez des questions, on pourra rester en contact par mail. J'espère que vous avez un peu compris.

Ziad, Zineb, Nidal, est-ce que ça a été ou vous avez encore des questions? Une petite question, s'il vous plaît. Si on a une limitation de la mobilisation active seule, est-ce qu'on parle de raideur seule? Oui, une mobilisation active, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à faire. Un âge peut lui faire, lui, il n'arrive pas à faire.

C'est soit que c'est une rupture tendineuse, soit que c'est une tendinopathie douloureuse, tout simplement. Ma question, est-ce qu'on parle de raideur ou non? Non, ce n'est pas une raideur. Un âge peut lui faire.

L'imitation de la mobilité active seule, la mobilité passive se fait normalement, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, dites-moi encore, si quelqu'un a une question. Zineb, Mona.

Alors, Khalid, Khalid, tu m'as dit Khalid, tu m'as dit Khalid, Khalid, Khalid, mobilisation passive et active différence. Khalid, la mobilisation active, c'est toi qui l'as fait, c'est le malade qui l'a fait. Mobilisation active, c'est-à-dire, elle est active, c'est toi qui fais, c'est le malade qui fait.

La mobilisation passive, c'est l'examineur qui fait. Moi, le patient, et moi, je lui fais la mobilisation. D'accord? C'est ça la différence.

Vos cours au niveau de la plateforme ne sont pas sonorisés, c'est-à-dire qu'on n'entend pas vos explications. Ce sont des cours qui sont très faciles, c'est pour ça que j'ai fait ce cours interactif. Il y a le premier cours qui est sonorisé, les autres non.

Ce sont des cours qui sont assez faciles, le tout est écrit, je ne vous demanderai pas quelque chose de plus que ça. Est-ce que vous pouvez programmer une autre séance? Je ne pense pas, parce qu'on est à la fin, et je n'ai que ce créneau. Il y a d'autres questions que je n'ai pas vues au début.

Alors, Nédal, qu'est-ce qu'il dit, madame? Est-ce qu'on peut dire que c'est une oligoarthrite? Bien sûr, c'est un, deux, trois. On peut dire oligoarthrite ou deux articulations, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir d'autres QCM? Madame, j'aurais aimé, mais le temps presse, il y a des gens qui vont venir après moi, je n'ai pas la plateforme toute seule.

Mouha, d'accord, merci beaucoup. Khawla, je vous en prie, il y a d'autres questions que j'ai zappées, je crois. Yasmin, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre adresse mail? Je vais voir avec la faculté, je vous le transmets.

Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres QCM? Rita, désolé, Rita, je n'ai plus le temps. Je vais voir tout de suite, mais je vous transmets mon adresse mail. Norman, est-ce que c'est possible de déposer les QCM sur la plateforme? D'accord, je ferai ça.

Je ferai ça ce soir. Avec d'autres QCM. La présence de gouttes ou de chondrocoïncidences fait partie, partie avec E. Rania, un médecin ne doit pas faire de faute d'orthographe, fait partie d'un épanchement inflammatoire, bravo, oui, ça fait partie d'un épanchement inflammatoire.

Voilà. Je crois que je dois vous quitter. On reste en contact.

Je vais déposer les QCM sur la plateforme. J'aimerais bien que vous voyiez ça de vive voix. Et j'arrive.

Voilà. À bientôt. Au revoir.

Merci, Yasmin. Merci tout le monde.